ROMA 난소암 위험도 검사, 확진이 아니라 "위험도를 가려주는" 검사입니다

이미 발견된 난소 혹이 암일 가능성이 높은 편인지 미리 가늠해, 처음부터 부인암 전문병원에서 진료받을지 정하는 데 쓰는 혈액검사입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

ROMA 검사, 세 가지만 기억하세요

암을 확정하는 검사가 아니라 '어디서 진료받을지'를 정하도록 돕는 검사입니다

1

위험도를 가늠하는 검사입니다

점수는 혹이 암일 가능성이 **높은 편인지 낮은 편인지**를 알려 줍니다. 암이라고 확정하지는 않습니다.

고위험이어도 양성 혹일 수 있고, 저위험이어도 추적이 필요할 수 있습니다.

확진은 수술·조직검사

2

이미 혹이 발견된 분이 받습니다

초음파 등에서 난소 혹이 보이고 수술을 앞둔 분이 대상입니다. 혹이 없는 분의 암 검진용이 아닙니다.

무증상 여성의 검진에 쓰도록 허가된 검사가 아닙니다.

대상: 난소 혹이 있는 분

3

목적은 알맞은 병원 찾기입니다

난소암은 처음부터 부인암 전문병원에서 수술받을 때 경과가 좋습니다. 점수가 높으면 그쪽으로 안내합니다.

그래서 점수는 '어디서 수술받을지'를 정하는 데 쓰입니다.

높으면 전문병원 안내

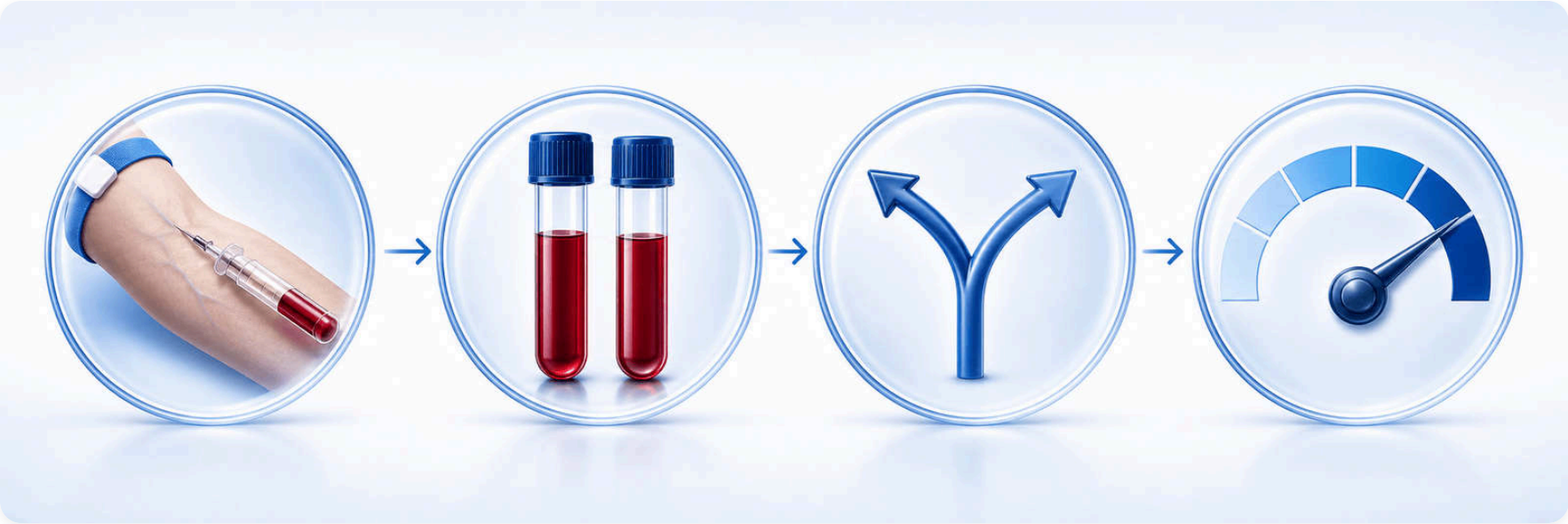
Tip · 점수 하나로 결정하지 않습니다. 초음파·CT 같은 영상과 진찰을 함께 봅니다.

근거 · Moore 2009 · ACOG 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

피 한 번으로 위험도 점수를 계산합니다

두 가지 혈액 표지자를 재고, 폐경 전·후에 따라 다른 계산식에 넣습니다



① 채혈 1회

팔에서 피를 한 번 뽑습니다 · 대개 금식 불필요

② 표지자 2가지

CA-125와 HE4 두 수치를 잽니다

③ 폐경 전·후

폐경 여부에 따라 다른 계산식을 씁니다

④ 위험도 점수

0~100% 점수로 높은 편·낮은 편을 나눕니다

Tip · 두 표지자는 서로의 약점을 보완합니다. 함께 볼 때 한 가지만 볼 때보다 구별이 좋아집니다.

근거 · Moore 2009 (Gynecol Oncol)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

ROMA 계산에 쓰는 폐경 상태를 먼저 확인합니다

월경이 멎은 기간만 보지 않고 나이·다른 원인·호르몬 사용을 함께 봅니다

45세 이상 자연 폐경

다른 뚜렷한 원인 없이 12개월 연속 무월경이면 호르몬 검사 없이 임상적으로 자연 폐경을 진단할 수 있습니다.

젊은 나이의 무월경

40~45세에 폐경 증상·월경 변화가 있으면 호르몬 검사를 고려합니다. **40세 미만**에서 폐경이 의심되면 조기난소부전 평가로 전환합니다.

마지막 월경일·무월경 기간과 난소 수술·항암·방사선 치료력을 알립니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

호르몬 사용 중이면 출혈만으로 폐경을 판단하지 않습니다

FSH 한 번의 값이나 월경 양상 하나로 단정하지 않습니다

피임약·호르몬 자궁내장치

호르몬 피임제나 호르몬 자궁내장치를 쓰면 **출혈 패턴만으로 폐경 여부를 판단할 수 없습니다.** 현재 치료와 사용 기간을 알려 주세요.

FSH 변동·임신 가능성

폐경 이행기에는 FSH가 크게 변해 **단회 검사로 폐경을 확정하지 않습니다.** 간헐적 배란과 임신 가능성이 있어 임신도 배제하고 피임 상담을 함께 합니다.

월경·호르몬 사용 기록으로 폐경 상태를 확인한 뒤 점수를 해석합니다.

아산 28회 연수강좌 — 월경이 불규칙한 환자, 무엇을 확인해야 하나?(이사라)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

CA-125와 HE4 — 약점이 서로 다릅니다

하나만으로는 부족해서 둘을 함께 봅니다

CA-125

가장 널리 쓰는 **난소암 표지자**입니다.

- 상피성 난소암의 80% 이상에서 올라갑니다
- 생리·임신·자궁내막증·근종·골반염에서도 오릅니다
- 그래서 폐경 전에는 **암이 아닌데 높게** 나오는 일이 많은 편입니다
- 혼자서는 양성·악성을 충분히 구별하지 못합니다

vs

HE4

CA-125를 **보완하는 표지자**입니다.

- 자궁내막증·근종 같은 양성 상태에서는 비교적 덜 오릅니다
- 콩팥 기능이 떨어졌거나 나이가 많거나 흡연하면 오를 수 있습니다
- 임신 중에는 오히려 낮아지는 경향이 있습니다
- 역시 혼자서는 진단하지 못해 CA-125와 함께 봅니다

Tip · 두 수치 모두 '오를 수 있는 다른 이유'가 있어 검사 전에 몸 상태를 알려 주시면 해석이 정확해집니다.

근거 · ACOG 2016 · Bolstad 2012

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

누가 · 어떻게 받는 검사인가요

이미 발견된 난소 혹의 성격을 가늠하기 위한 검사입니다

이런 분이 받습니다

난소 혹이 발견돼 수술이 계획된 만 18세 넘은 여성(폐경 전·후)으로, 아직 부인암 전문의에게 의뢰되지 않은 분입니다.

이런 용도는 아닙니다

증상도 혹도 없는 분의 **암 검진(스크리닝)**, 혼자서 암을 확정하는 일, 치료 뒤 재발을 지켜보는 일에는 쓰지 않습니다.

검사 방법

정맥에서 피를 한 번 뽑습니다. 대개 금식은 필요 없습니다. 두 수치와 폐경 상태로 점수를 계산합니다.

검사하는 이유

점수가 높은 편이면 처음부터 난소암을 전문으로 보는 병원에서 평가·수술받도록 안내하기 위해서입니다.

Tip · 검진 목적으로 받고 싶다면 이 검사보다 먼저 담당 의사와 어떤 검사가 맞는지 상의하세요.

근거 · 제조사 허가 사용 목적 · ACOG 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

기준값을 넘으면 '고위험'으로 분류합니다

기준값은 검사 장비·시약마다 다릅니다 — 검사한 곳의 기준을 따릅니다

검사 장비·시약	폐경 전 고위험	폐경 후 고위험	읽는 법
Roche(Cobas · Elecsys)	**11.4%** 이상	**29.9%** 이상	기준값 이상이면 고위험
Abbott(Architect)	약 **7.4%** 이상	약 **25.3%** 이상	장비마다 기준이 다름

폐경 전 기준이 더 낮은 이유

폐경 전에는 생리·자궁내막증 때문에 CA-125가 암이 아닌데도 오르는 일이 많아, 기준을 따로 잡습니다.

다른 병원 점수와 비교하지 마세요

장비·시약이 다르면 같은 숫자도 뜻이 달라집니다. 이전 결과가 있으면 어디서 검사했는지 함께 알려 주세요.

Tip · 점수는 영상·진찰과 함께 종합해 판단합니다.

근거 · Roche·Abbott 제조사 기준값

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

점수가 높으면 암인가요?

고위험이 곧 암은 아니고, 저위험이 100% 안심도 아닙니다

⚠ 고위험으로 나와도

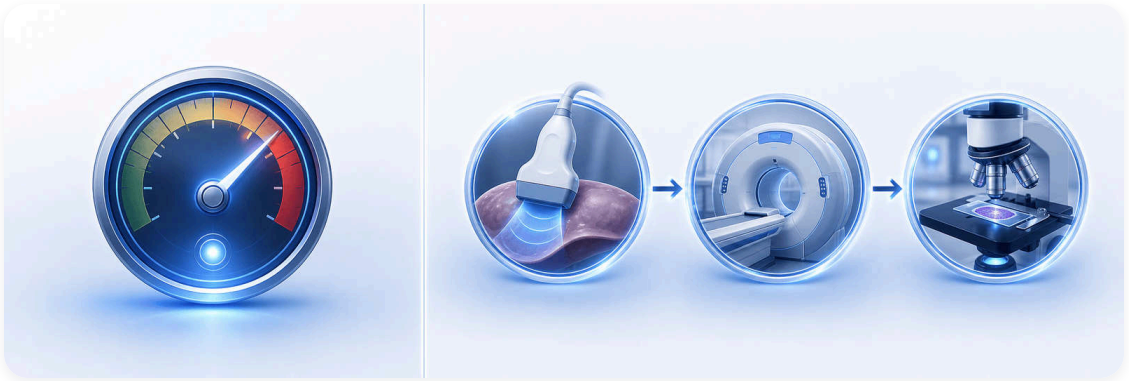
양성 혹이거나 다른 이유로 수치가 오른 **위양성**일 수 있습니다. 전문병원에서 영상·진찰로 더 자세히 봅니다.

저위험으로 나와도

실제 암을 놓치는 **위음성**이 있을 수 있습니다. 그래서 저위험이라고 추적을 그만두지 않습니다.

성능은 범위로 봅니다

연구마다 민감도 76~92%, 특이도 67~93%로 나타났습니다. 점수는 판단을 돕는 한 가지 자료입니다.



85.3%

민감도 — 암을 찾아내는 정도
(여러 연구를 합친 추정치)

82.4%

특이도 — 암이 아닌 것을 거르는 정도
(여러 연구를 합친 추정치)

Tip · 최종 진단은 수술로 떼어 낸 조직을 현미경으로 보는 조직검사로 확인합니다.

근거 · Wang 2014 메타분석(AAFP 2023 인용) · Moore 2009

암이 아닌데 수치가 오르는 경우

이런 상황에서는 점수가 높게 나올 수 있어 미리 알려 주시면 해석에 도움이 됩니다



검사 전에 알려 주세요

생리 주기와 임신 가능성, 자궁내막증·근종 같은 부인과 병력, 콩팥 질환, 흡연 여부를 말씀해 주세요.

생리 · 임신 초기
CA-125가 자연스럽게 오를 수 있습니다

자궁내막증 · 근종 · 선근증
자궁내막증은 보통 100 미만으로 오릅니다

골반 염증(골반염)
염증이 있으면 수치가 오를 수 있습니다

복막 · 흉막 자극
복부 수술 뒤·복막염·흉수 등

심부전 · 간경화 · 복수
암과 관계없이 수치가 오를 수 있습니다

콩팥 기능 저하 · 고령 · 흡연
HE4가 오를 수 있습니다

Tip · 이런 이유가 있으면 담당 의사가 점수를 더 조심스럽게 해석합니다.

근거 · ACOG 2016 · Bolstad 2012

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

폐경 후 출혈은 ROMA 점수와 별개로 평가합니다

소량이거나 잠깐 멎은 출혈도 원인을 확인합니다

자궁내막 원인 확인

폐경 후 출혈은 **자궁내막암 등 원인을 배제**합니다. 비만·가족력·타목시펜 복용을 알리고 출혈량·기간, 기존 초음파 결과를 가져오세요.

자궁경부도 확인

성교 후 출혈 여부와 최근 자궁경부 세포검사·HPV 결과, 검진 날짜를 전달합니다. 폐경 상태 확인과 실제 출혈 원인 평가를 산부인과에서 함께 진행합니다.

ROMA가 저위험이어도 폐경 후 출혈 평가를 대신하지 못합니다.

아산 28회 연수강좌 — 월경이 불규칙한 환자, 무엇을 확인해야 하나?(이사라)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

고위험으로 나오면 이렇게 진행합니다

'전문병원에서 볼지' 정하는 신호입니다 — 이 순서로 진행합니다

① 부인암 전문의에게 의뢰

가능성이 높은 편이면 난소암을 전문으로 보는 병원에서 평가·수술받도록 안내합니다.

② 추가 영상·진찰

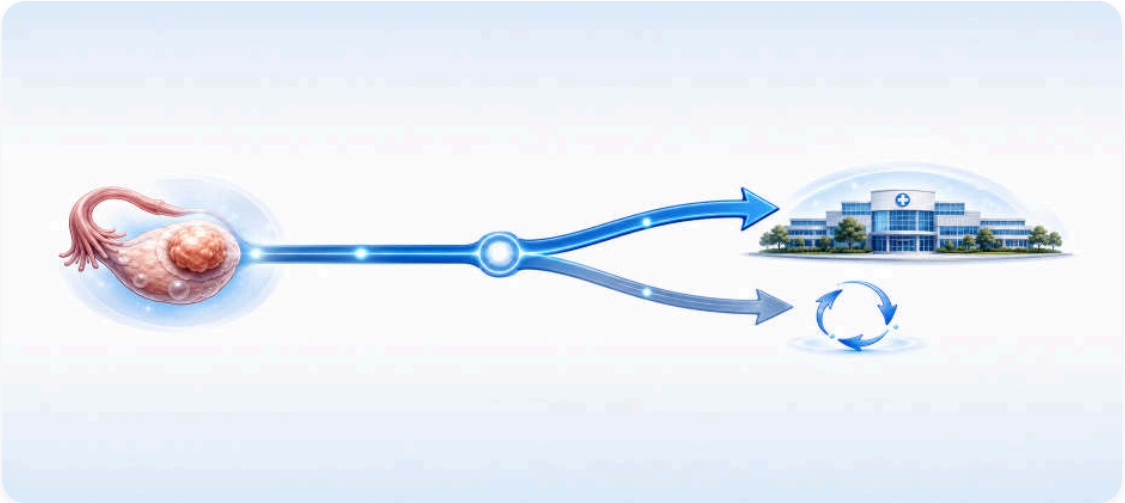
정밀 초음파·CT·MRI로 혹의 성질을 더 자세히 봅니다.

③ 필요하면 수술·조직검사

최종 진단은 수술과 조직검사로 확인합니다.

저위험이어도 추적합니다

증상과 영상 소견에 따라 추적 관찰이나 추가 검사를 합니다.



점수만으로 암을 확정하지 않습니다 — 영상·진찰·조직검사가 함께 갑니다

Tip · 저위험 결과를 받았어도 증상이 새로 생기거나 심해지면 진료를 받으세요.

근거 · ACOG 2016 · Moore 2009

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

검사부터 결과 설명까지 네 단계

검사 전에 알릴 것과 결과를 들을 때 기억할 것을 순서대로 모았습니다

1 알리기

임신 가능성·생리 주기, 자궁내막증·근종 병력, 콩팥 질환, 흡연 여부를 먼저 말씀해 주세요.

수치를 올리는 이유 미리 확인

2 채혈

팔에서 피를 한 번 뽑습니다. 대개 금식은 필요 없습니다.

대개 금식 불필요

3 점수 계산

두 수치와 폐경 상태로 점수를 내고, 검사한 곳의 기준값으로 높은 편·낮은 편을 나눕니다.

기준값은 장비·시약마다 다름

4 결과 설명

점수만이 아니라 영상·진찰 소견과 함께 설명을 듣고 다음 단계를 정합니다.

영상·진찰과 함께 판단

다른 병원의 점수와 단순 비교하지 않고, 수치 하나로 결론 내리지 않습니다

Tip · 궁금한 점은 결과를 들을 때 바로 물어보세요.

근거 · Moore 2009 · 제조사 사용 설명

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

ROMA 검사를 한 장으로 정리하면

무엇을 · 누가 · 어떻게 · 결과 뒤에 무엇을 하는지

질문	답
무엇인가요	난소 혹이 암일 가능성이 **높은 편인지** 가늠하는 혈액검사입니다
누가 받나요	난소 혹이 발견돼 수술이 계획됐고, 아직 부인암 전문의에게 의뢰되지 않은 만 18세 넘은 여성
어떻게 하나요	채혈 1회 → 두 표지자 + 폐경 상태로 점수 계산
결과는	기준값 이상이면 고위험 · 기준값은 장비·시약마다 다름
그다음은	고위험이면 전문병원 의뢰와 추가 영상 · 저위험이어도 필요하면 추적

Tip · 최종 진단은 수술과 조직검사로 확인합니다.

근거 · Moore 2009 · ACOG 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

난소 혹이 발견돼 ROMA 검사를 앞둔 분을 위한 설명자료입니다. 검사와 치료 결정은 담당 의료진과 상의해 정합니다.

참고한 자료

Moore RG 등, Gynecol Oncol 2009(ROMA 개발) · ACOG Practice Bulletin 174(2016, 부속기 종괴) · Wang 등 2014 메타분석(AAFP 2023 인용) · Bolstad 2012(HE4 기준치) · Roche·Abbott 제조사 기준값

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요